

RELATÓRIO MÉDICO

Complexo Hospitalar Universitário Simulado • Departamento de Clínica Médica

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:	Carlos Eduardo dos Santos (Fictício)	Idade:	54 anos
Sexo:	Masculino	Data de Nasc.:	12/04/1972
Prontuário:	948.302-A	Data do Atend.:	01/06/2026

QUEIXA PRINCIPAL

Dor torácica de início súbito associada a desconforto respiratório há aproximadamente duas horas.

ANAMNESE / HISTÓRICO CLÍNICO

Paciente masculino, 54 anos, previamente diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia em tratamento irregular, compareceu à unidade de emergência relatando dor retroesternal de forte intensidade (graduada em 8/10 na escala visual analógica), de caráter opressivo, com irradiação para o membro superior esquerdo e região cervical. O quadro clínico iniciou-se em repouso há cerca de duas horas e não apresentou melhora após o uso de analgésicos comuns no domicílio. Associa-se ao quadro sudorese fria profusa, náuseas e dispneia de intensidade moderada. O paciente nega episódios semelhantes pregressos. Como antecedentes familiares, destaca histórico de doença arterial coronariana precoce em parente de primeiro grau (pai falecido por infarto agudo do miocárdio aos 50 anos). Nega tabagismo, etilismo ou outras comorbidades conhecidas.

EXAME FÍSICO

Ao exame geral, o paciente encontra-se em regular estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço, porém ansioso, álgico, acianótico, anictérico, febril e visivelmente sudorético. O exame do aparelho cardiovascular revela ritmo cardíaco regular em dois tempos, com bulhas hipofonéticas, sem sopros audíveis e ausência de atrito pericárdico. Os pulsos periféricos encontram-se palpáveis, simétricos e com amplitude preservada. O exame do aparelho respiratório evidencia murmúrio vesicular presente bilateralmente, com presença de estertores crepitantes discretos em bases pulmonares; expansibilidade torácica mantida. O abdômen apresenta-se plano, flácido, indolor à palpação superficial e profunda, sem massas ou visceromegalias palpáveis e com ruídos hidroaéreos presentes. Membros inferiores sem edema, sem sinais clínicos de trombose venosa profunda e com perfusão periférica lentificada (tempo de enchimento capilar de 3 segundos).

Sinais Vitais na Admissão: Pressão Arterial: 165/95 mmHg; Frequência Cardíaca: 104 bpm; Frequência Respiratória: 22 irpm; Saturação de Oxigênio: 93% em ar ambiente; Temperatura Axilar: 36,4 °C.

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS

Considerando a apresentação clínica clássica de dor torácica opressiva irradiada com fatores de risco cardiovasculares significativos e alterações ao exame físico, estabeleceram-se como principais hipóteses diagnósticas: 1. Síndrome Coronariana Aguda com ou sem supradesnívelamento do segmento ST (SCA); 2. Dissecção Aguda de Aorta (a esclarecer por exames de imagem); 3. Tromboembolismo Pulmonar (TEP).

CONDUTA INSTITUÍDA E EVOLUÇÃO INICIAL

O paciente foi imediatamente monitorizado e posicionado em leito de emergência. Instituiu-se oxigenoterapia suplementar via cateter nasal de oxigênio a 2 L/min devido à dessaturação inicial. Realizou-se de forma imediata eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, o qual evidenciou inversão dinâmica de onda T e infraesnivelamento estável do segmento ST de 1,5 mm nas derivações de parede anterior (V2 a V5), sugerindo isquemia miocárdica aguda sem supradesnivelamento do segmento ST. Foram coletados exames laboratoriais de urgência, incluindo hemograma completo, função renal, eletrólitos, coagulograma e marcadores de necrose miocárdica (Troponina I ultrasensível, com resultado da primeira curva discretamente elevado em 45 ng/L).

A terapêutica medicamentosa anti-isquêmica e anti-trombótica de urgência foi iniciada com a administração de Ácido Acetilsalicílico (AAS) 200 mg (mastigável) e Ticagrelor 180 mg (dose de ataque), associados à anticoagulação plena com Enoxaparina sódica 80 mg por via subcutânea. Administrou-se também Nitroglicerina por via intravenosa contínua para controle da dor e da pressão arterial, obtendo-se melhora parcial do sintoma álgico (redução para 2/10).

RECOMENDAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTO

Frente ao diagnóstico firmado de Síndrome Coronariana Aguda Sem Supradesnivelamento do Segmento ST (SCASSST) de moderado a alto risco, o paciente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiológica para monitorização contínua. Recomenda-se repouso absoluto no leito, jejum nas primeiras horas para reavaliação, manutenção da dupla antiagregação plaquetária e da anticoagulação conforme protocolo institucional, além da dosagem seriada de marcadores de necrose miocárdica a cada 3 horas. Solicita-se a realização de Ecocardiograma Transtorácico nas próximas 12 horas e o agendamento de Estratificação Invasiva com Cineangiocoronariografia (Cateterismo Cardíaco) dentro das próximas 24 horas para avaliação da anatomia coronariana e definição de conduta intervencionista definitiva.

Dr. Alexandre de Oliveira (Fictício)

Médico Plantonista — Clínica Médica

CRM/UF: 000000-SP